PROTOCOLLO 38

Trazione cranio-mandibolare globale

Ridurre la tensione del distretto cranio-mandibolare con una tecnica globale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Tutte	Dolore misto	5 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Tensione diffusa del distretto
- ✓ Dolore misto muscolare e articolare
- ✓ Pazienti molto sensibili alle tecniche locali

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: alla testa del lettino, una mano sotto l'occipite e una sul mento.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Mani a coppa sotto l'occipite e sulla mandibola.



Trazione

Lieve trazione in direzione cranio-caudale.



Respirazione

Il paziente respira lentamente durante la tenuta.



Rilascio

Riduci gradualmente la trazione.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	3
Intensità	molto lieve

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Tecnica ben tollerata e rilassante
- ✓ Sincronizza con la respirazione
- ✓ Ideale a inizio o fine seduta

Errori da evitare

- ! Trazione eccessiva
- ! Presa sul collo anteriore
- ! Movimenti bruschi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilassamento guidato	Respirazione lenta con mandibola rilassata	5 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Le tecniche globali preparano il paziente a quelle locali e riducono l'ipervigilanza.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.